Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — IV

À RETENIR

- Associe **périostose des os longs** + **hippocratisme digital**.
- Retrouvée dans : pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
- Hyperfixation **linéaire corticale** des os longs, métaphyso-diaphysaire distale > proximale, **respect des épiphyses** → « **rails de chemin de fer** ».
- + hyperfixation péri-articulaire (synovite) + hippocratisme digital (métacarpes, phalanges proximales et moyennes).
- Atteinte asymétrique des extrémités dans **15 %** des cas.
- Suivi : l'hyperfixation régresse au cours du **1er mois** d'un traitement efficace, alors que la radiographie reste inchangée.
- Diagnostic différentiel : **pachydermopériostose** (autosomique dominante).

1. Définition

C'est le syndrome de Pierre Marie et Foix, qui associe :

1. une périostose des os longs ;
2. un hippocratisme digital.

Retrouvé dans :

1. pneumopathies chroniques ;
2. tumeurs bronchopulmonaires ;
3. cardiopathies cyanogènes.

2. Indications de la SO

- Sévérité.
- Pronostic.
- Suivi : l'hyperfixation **régresse au cours du premier mois** d'un traitement efficace, avec des signes radiographiques inchangés.

3. Sémiologie scintigraphique

a. Forme typique

1. **Hyperfixation linéaire soulignant la corticale des os longs**, plus fréquemment au niveau métaphyso-diaphysaire distal que proximal, avec respect des épiphyses. Lorsque l'hyperfixation est intense et étendue ⇒ « **image en rails de chemin de fer** ».
2. Hyperfixation péri-articulaire = **synovite**.
3. **Hippocratisme digital** = hyperfixation des métacarpes, phalanges proximales et moyennes (« statique = main »).

b. Variantes scintigraphiques

- Atteinte asymétrique (des articulations et) des extrémités dans **15 %** des cas.
- L'atteinte peut également intéresser le crâne (maxillaire, mandibule), les clavicules, la mandibule, les omoplates, la rotule, le calcanéum, le gril costal, la symphyse pubienne et les ailes iliaques.

4. Diagnostic différentiel

Pachydermopériostose (PDP) : maladie héréditaire, à transmission autosomique dominante de pénétrance variable.

5. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéoarthropathie = Pierre Marie et Foix ; diagnostic différentiel = pachydermopériostose (« S. étiologie » : sans étiologie, c.-à-d. forme idiopathique).
- ① Périostose (↑ fixation linéaire des corticales des os longs, MI ++, méta-diaphysaire distale, respect des épiphyses : rails de chemin de fer) ; ② synovite (↑ péri-articulaire) ; ③ hippocratisme digital.
- SO → intérêt : poussée ; suivi thérapeutique = ↓ fixation ; sévérité (verso du pense-bête, p. 37).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les deux éléments du syndrome de Pierre Marie et Foix ?	Périostose des os longs + hippocratisme digital.
2. Dans quelles pathologies le retrouve-t-on ?	Pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes.
3. Décrivez l'image en « rails de chemin de fer ».	Hyperfixation linéaire intense et étendue des corticales des os longs, métaphyso-diaphysaire distale, respectant les épiphyses.
4. Que traduit l'hyperfixation péri-articulaire ?	Une synovite.
5. Fréquence de l'atteinte asymétrique des extrémités ?	15 % des cas.
6. Comment évolue la SO sous traitement efficace ?	L'hyperfixation régresse au cours du 1er mois, la radiographie restant inchangée.
7. Principal diagnostic différentiel ?	La pachydermopériostose (autosomique dominante, pénétrance variable).